康复护理对多发性硬化言语及吞咽障碍的临床效果

李金凤，闵　慧*，王彤彤，李　笑，孙丽君
徐州市康复医院，江苏　徐州　221000

【摘要】**目的**　分析多发性硬化言语及吞咽障碍患者应用康复护理的效果。**方法**　选取我院2023年1月至2023年11月收治的63例多发性硬化言语及吞咽障碍患者，随机分为两组，对照组（30例）实施常规护理措施，试验组（33例）在常规护理的基础上运用康复护理，比较两组护理效果。**结果**　试验组言语及吞咽功能评分高于对照组，护理总有效率高于对照组，生活质量评分高于对照组（$P < 0.05$）。**结论**　在多发性硬化言语及吞咽障碍患者的护理中应用康复护理能有效改善其言语功能及吞咽功能。

【关键词】康复护理；多发性硬化；言语；吞咽；障碍
【中图分类号】R473　【文献标识码】A
DOI:10.16282/j.cnki.cn11-9336/r.2024.05.027

Effect of rehabilitation nursing on speech and swallowing disorders in multiple sclerosis

Li Jinfeng, Min Hui *, Wang Tongtong , Li Xiao, Sun Lijun
Xuzhou Rehabilitation Hospital, Xuzhou 221000, China

【**Abstract**】**Objective**　To analyze the effect of rehabilitation nursing for patients with speech and swallowing disorders after multiple sclerosis. **Methods**　63 patients with speech and swallowing disorders after multiple sclerosis admitted to our hospital from January 2023 to November 2023 were randomly divided into two groups：the control group（30 cases）received routine nursing measures, and the experimental group（33 cases）received rehabilitation nursing on the basis of routine nursing. The nursing effects of the two groups were compared. **Results**　Compared with the control group, the scores of speech and swallowing function in the experimental group were higher, the total effective rate of nursing was higher, and the quality of life score was higher（$P < 0.05$）. **Conclusion**　Rehabilitation nursing can effectively improve the speech function and swallowing function of patients with multiple sclerosis.

【**Key words**】rehabilitation nursing; multiple sclerosis; speech; swallow; disorder

多发性硬化是一种自身免疫病，主要是中枢神经脱髓鞘引起的功能障碍，发病后的主要表现有肢体乏力、感觉异常、言语不清、强直痉挛、记忆力减退及吞咽障碍等[1]，其中言语及吞咽障碍最为常见，不仅影响患者的正常交流，还会造成营养不良，严重降低患者的生活质量，除基础性药物治疗外应主动开展针对性护理予以改善[2]。有文献指出，康复护理在多发性硬化言语及吞咽障碍患者治疗中能发挥重要作用，能指导患者主动开展系统的机械性训练，充分刺激口腔与咽壁肌肉，在神经反馈调节下能逐渐恢复口腔正常功能[3]。为此，本次研究选取我院收治的63例多发性硬化言语及吞咽障碍患者，旨在探究康复护理的应用价值，具体内容如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料

选取我院2023年1月至2023年11月收治的63例多发性硬化言语及吞咽障碍患者，随机分为两组，试验组（n=33例）中，男性17例，女性

通信作者：闵慧，E-mail：3183697302@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

16 例；年龄 30~68 岁，平均年龄（45.59 ± 3.73）岁；病程 5~21 周，病程均值（12.17 ± 1.26）周；吞咽障碍分级：5~6 级障碍有 18 例，3~4 级障碍 11 例，2 级障碍 3 例，1 级障碍 1 例。对照组（n=30 例）中，男性 18 例，女性 12 例；年龄 29~67 岁，平均年龄（45.32 ± 3.64）岁；病程 6~22 周，病程均值（12.24 ± 1.39）周；吞咽障碍分级：5~6 级障碍有 16 例，3~4 级障碍 9 例，2 级障碍 4 例，1 级障碍 1 例。两组一般资料比较，差异无统计学意义（$P > 0.05$），具有可比性。

纳入标准：经颅脑磁共振及洼田饮水试验等检测确诊为多发性硬化言语及吞咽障碍；1 个月内未接受过相关治疗；患者或家属对本研究知晓且在同意书上签字。

排除标准：合并心、脑、肾等器官功能障碍；精神异常或认知障碍；合并帕金森病或阿尔茨海默病；无法坚持完成研究干预。

1.2　方法

两组患者均接受免疫球蛋白、免疫抑制剂、糖皮质激素及 β– 干扰素治疗。

对照组实施常规护理，简单讲解多发性硬化症的相关知识，告知患者及家属自行开展言语及吞咽功能基础训练。

试验组实施康复护理。

（1）心理疏导：言语及吞咽功能恢复需要经历漫长的训练周期，受病情影响患者会产生惰性心理与焦虑、抑郁等消极情绪，护理人员主动与患者沟通告知其通过系统的康复训练能恢复正常言语及吞咽功能，分享康复案例增强其治疗信心，定期开展心理疏导缓解患者不良情绪，邀请家属共同鼓励患者积极配合治疗。

（2）康复认知教育：为患者提供整洁、舒适的康复环境，全面普及多发性硬化病的相关知识，鼓励患者主动参加健康讲座或观看录制视频，让患者对自身疾病更加了解，掌握基本的护理技能，提高其自我护理意识，提高其治疗依从性，为后续康复训练开展奠定良好的基础。

（3）吞咽训练：播放吞咽相关视频讲解吞咽技巧，引导患者自主进行空吞咽动作，可适当给予少量温水让患者练习吞咽动作，后续可循序渐进给予糊状或胶状食物让患者吞咽，如苹果泥、地瓜泥、米糊等，每次练习要秉承着少量多次原则，当患者吞咽糊状食物不发生呛咳时可进行进食正常食物，由流质、半流食逐渐过渡到正常进食。

（4）言语训练：先指导患者练习开音节与闭音节，告知患者掌握口型变化、舌肌发力的技巧，从最简单的字、词、短语开始训练，可配合肢体语言便于患者理解，及时纠正其错误发音，发音正确可进行语言鼓励，定期通过声带内收、喉位上提、吸吮训练等动作刺激口腔肌肉，可配合冰刺激、针灸等辅助治疗提升言语训练效果，促使患者逐渐恢复言语功能。

1.3　观察指标

以我院自拟言语功能及吞咽功能评定表评估患者的言语及吞咽功能，Cronbach α 系数为 0.904，信效度较为理想，总分为 10 分，评分越高表示患者言语及吞咽功能恢复越好。

根据患者临床表现评定护理效果，具体标准如下：吞咽障碍等级下降 2 级及以上，能正常进食，言语障碍基本消失，能正常交流为显效；吞咽障碍等级下降 1 级，可进流食，言语障碍有所改善，部分话语能表达清晰为有效；吞咽障碍及言语障碍均未发生明显变化或加重，无法完成经口进食，仍存在交流障碍为无效。总有效率 =（显效例数 + 有效例数）/ 总例数 ×100%。吞咽障碍共分为 7 个等级：存在唾液误咽，完全不能经口饮水及进食为 1 级；对于流食及水分存在误吸表现，基本不能完成经口进食为 2 级；通过调整姿势能咽下部分食物，但饮水后仍有误吸现象为 3 级；普通进食存在误咽现象为 4 级；普通进食不存在误吸现象，但口腔内残留食物增多，进食时间较长为 5 级；普通进食有咀嚼不充分现象，口腔残留食物减少为 6 级，无吞咽障碍为 7 级。

采用 SF–36 健康调查简表（SF–36）评定患者的生活质量，共涉及 8 个维度，36 个条目，各维度分值均为 100 分，分数越高代表患者的生活质量越好。

1.4　统计学方法

以 SPSS 25.0 软件进行统计。生活质量、言语及吞咽功能评分以 $\bar{x} \pm s$ 形式表示，采用 t 检验；护理效果通过 n（%）形式表示，采用 χ^2 检验。$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　两组言语及吞咽功能评分对比

护理前，两组患者言语及吞咽功能评分对比，

中国知网　https://www.cnki.net

差异无统计学意义（$P > 0.05$）；护理后，试验组言语及吞咽功能评分高于对照组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 1。

2.2 两组护理效果对比

试验组护理总有效率高于对照组，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 2。

2.3 两组生活质量评分对比

试验组生活质量方面评分相比于对照组更高，差异有统计学意义（$P < 0.05$）。见表 3。

表 1 两组言语及吞咽功能评分对比（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	言语功能		吞咽功能	
		护理前	护理后	护理前	护理后
试验组	33	4.19 ± 0.68	7.95 ± 1.29	3.83 ± 0.57	7.84 ± 1.18
对照组	30	4.26 ± 0.72	6.53 ± 1.07	3.92 ± 0.59	6.13 ± 0.87
t		0.3968	4.7284	0.6156	6.4919
P		0.6929	0.0000	0.5405	0.0000

表 2 两组护理效果对比［n（%）］

组别	例数	显效	有效	无效	总有效率
试验组	33	19（57.58）	13（39.39）	1（3.03）	32（96.97）
对照组	30	10（33.33）	11（36.67）	9（30.00）	21（70.00）
χ^2					8.5596
P					0.0034

表 3 两组生活质量评分对比（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	例数	社会功能	一般健康状况	躯体疼痛	情感职能	精力	生理职能	生理功能	精神健康
试验组	33	82.74 ± 5.31	84.61 ± 5.24	89.53 ± 4.36	85.17 ± 5.27	84.63 ± 4.52	85.59 ± 5.56	84.93 ± 4.31	85.57 ± 5.14
对照组	30	76.55 ± 4.25	78.57 ± 4.31	84.34 ± 3.53	80.31 ± 4.52	79.69 ± 3.79	81.35 ± 4.39	80.15 ± 3.29	81.26 ± 4.63
t		5.0749	4.9672	5.1602	3.9097	4.6750	3.3364	4.9104	3.4839
P		0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0014	0.0000	0.0009

3 讨论

多发性硬化是中枢神经脱髓鞘引起的脑白质炎性病变，其发病与遗传基因、免疫缺失、病毒感染及危险环境等因素存在密切联系，疾病会呈现出慢性神经性损伤，直接对视觉、听觉、感觉、言语及吞咽等功能造成严重影响。由于患者缺乏对疾病的认知，在发病后无法正常沟通及进食，会产生强烈的焦虑、抑郁等不良情绪，甚至会引发营养不良，危及患者的生命安全，故尽早开展有效的治疗及护理措施促使其病情改善意义重大[4]。临床针对多发性硬化通常采用免疫性抑制剂及免疫球蛋白治疗，可纠正患者的免疫系统，缓解神经炎性病变，但对于言语及吞咽障碍的作用甚微，需要配合科学的护理措施[5]。康复护理是临床应用比较广泛的护理方法，能针对个别神经功能障碍开展针对性康复训练，在机械性的运动反射下促进其正常功能恢复[6]。吞咽康复训练通过亲身演示引导患者自主进行吞咽动作，从水、糊状食物、流质、半流食逐渐过渡到正常食物，配合冰刺激及针灸促使患者吞咽功能逐渐恢复；言语康复训练中指导患者从音节、单字、词组及短语不断过渡，及时纠正其错误的发音，让患者逐渐掌握语言发声技巧，配合声带内收、喉位上提、吸吮训练等动作刺激口腔肌群增强其言语控制能力，使患者的言语功能逐渐恢复[7-8]。此外，康复护理能在患者训练过程中不断

中国知网 https://www.cnki.net

进行疏导及鼓励，协同家属引导患者减轻心理压力，调节情绪状态，可提高患者治疗依从性，有助于加快康复进程[9]。

结果表明，试验组言语及吞咽功能评分高于对照组，护理总有效率高于对照组，生活质量评分高于对照组（$P < 0.05$）。提示，康复护理能显著提高患者的吞咽功能及言语功能，使其生活质量有所改善，可提高整体护理质量及效果。分析其原因为，康复护理能根据患者的实际症状开展个性化的护理计划，循序渐进开展科学有效的康复锻炼刺激大脑神经系统重建，增强肌肉记忆及信号传递，合理进行口腔肌肉训练能刺激声带内收及喉部上提，调节言语控制能力，渐进式的吞咽训练可逐渐改善患者的吞咽功能，配合心理疏导及鼓励可增强患者的治疗信心，实现更理想的护理效果[10]。

综上所述，康复护理在多发性硬化言语及吞咽障碍患者的护理中能取得显著的护理效果，能有效改善患者言语功能及吞咽功能，提高其生活质量。

参 考 文 献

[1] 邓晓艳．康复护理对多发性硬化言语及吞咽障碍患者的作用研究［J］．养生保健指南，2021（9）：138．

[2] 王晓燕．康复护理对多发性硬化言语及吞咽障碍患者的影响［J］．医学食疗与健康，2019（1）：91–92．

[3] 李鸿春．康复护理对多发性硬化言语及吞咽障碍患者的影响［J］．医学食疗与健康，2019（1）：87–88．

[4] 骆宇菲，闵玉霞．康复护理对多发性硬化言语及吞咽障碍患者的影响［J］．实用临床护理学电子杂志，2018，3（23）：67．

[5] 徐艳艳，付涵．康复护理对多发性硬化言语及吞咽障碍患者的作用研究［J］．药店周刊，2021，30（46）：105–106．

[6] 李加欢．康复护理对多发性硬化言语及吞咽障碍患者的影响［J］．药店周刊，2021，30（45）：90–92．

[7] 贾庆双．吞咽言语治疗仪联合多种康复治疗脑卒中吞咽障碍的预后分析［J］．中国医药指南，2020，18（9）：154–155．

[8] 张奕雯，Lancy H，邱卓英，等．基于世界卫生组织国际分类家族构建言语嗓音功能障碍的诊断、评估和康复体系［J］．中国康复理论与实践，2020，26（1）：37–44．

[9] 赵丽，丁慧，毛二莉，等．多发性硬化患者运动康复干预的研究进展［J］．中国临床护理，2022，14（12）：778–781．

[10] 黄宝和，是明启，张弘娟．康复疗法对于多发性硬化缓解期患者神经功能、疲劳度及血清 MMP–9、TIMP–1 表达的影响［J］．中国卫生工程学，2021，20（2）：244–247．

中国知网　https://www.cnki.net